

Patient's Name : _____

MRN : _____

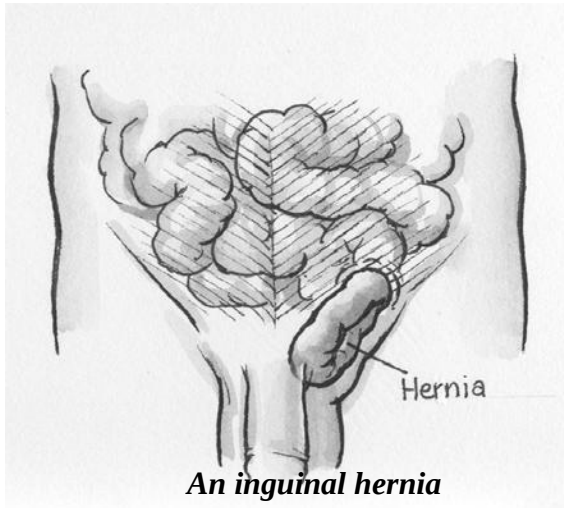
DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Hernia – Laparoscopic Inguinal Hernia Repair

معلومات الإقرار – نسخة المريض الفتق-إصلاح الفتق الإربي بالمنظار

1. What do I need to know about this condition?

A hernia, sometimes referred to as a rupture, occurs when a part of an internal organ, sometimes the bowel, pushes through a weak point in the abdominal wall.



Inguinal hernia is the most common type of hernia, and twenty times more common in men than in women. It is likely that about 1 in 20 men will develop an inguinal hernia. The inguinal canal is in the groin. The first signs of a hernia are pain and/or a lump.

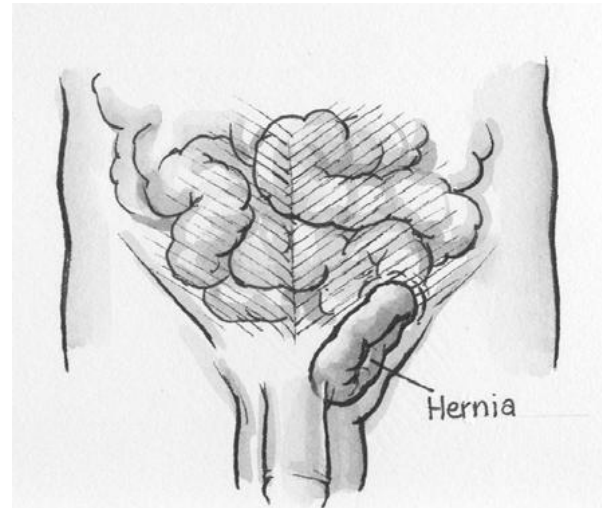
2. What do I need to know about this procedure?

Laparoscopic repair

- Laparoscopy or key-hole surgery is performed under general anaesthetic. Small cuts are made in the abdomen. Instruments are pushed into the holes and carbon dioxide gas is blown into the abdomen to lift the abdominal wall away from the internal organs so that the surgeon has a good view.
- A nylon mesh is sewn and/or stapled in place

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذه الحالة المرضية؟

يحدث الفتق (يشار إليه أحياناً بالـ"تمزق") عندما يندفع جزء من أحد الأعضاء داخل الجسم (أحياناً الأمعاء) عبر نقطة ضعيفة في جدار البطن.



الفتق الأربي هو أكثر أنواع الفتوق شيوعاً ، و الرجال أكثر إصابة به من النساء . من المرجح أن يصاب 1 من كل 20 رجل بهذا الفتق. توجد القناة الأربية في منطقة أعلى الفخذ . إن أول علامات الإصابة بهذا الفتق هي الشعور بالألم و/أو ظهور كتلة (تورم).

2. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذه الحالة المرضية؟

الإصلاح بالمنظار

- الإصلاح الجراحي بالمنظار الجراحي يتم تحت التخدير الكلي. يتم عمل شقوق جراحية صغيرة في البطن. يتم إدخال الأدوات الجراحية عبر هذه الثقوب كما يتم ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون ونفخ البطن بحيث يتم إبعاد جدار البطن عن الأعضاء الداخلية مما يخلق فراغ يمكن الجراح من العمل ويحقق له رؤية واضحة.
- يتم تثبيت شبكة مصنوعة من مادة النايلون على المنطقة الضعيفة ، ويكون هذا التثبيت بخيوط جراحية و/أو التدبيس.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

over the weak area. The instruments are removed and the gas is allowed to escape before stitching or stapling the cuts together.

3. What are the benefits of having this procedure?

The pain and lump will be relieved by the surgery. Planned surgical treatment of a hernia is much safer than leaving the hernia until an emergency happens.

4. What are the risks of not having this procedure?

The hernia will probably get bigger. Inside, the bowel may become trapped and blocked or gangrenous (that part of the bowel dies). This can be very dangerous and will need emergency treatment. Treatment may require extensive surgery to the bowel.

5. What are some alternative treatments? Truss

A truss may be worn which applies support to the weak area. The truss is not a cure and can be uncomfortable. It may cause pressure sores and is not always effective. The proper use of a truss requires medical advice.

6. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

7. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

في نهاية الجراحة ، يتم إخراج الأدوات الجراحية والسماح للغاز بالخروج ثم تتم خياطة الشقوق الجراحية.

3. ما هي فوائد خضوعي لهذا الإجراء ؟

يتمثل الألم والتورم للشفاء بعد العملية . إن التخطيط لإجراء هذه العملية هو أكثر أمناً من ترك هذا الفتق دون علاج ومن ثم حدوث مضاعفات خطره له تتطلب تدخل طارئ.

4. ما هي مخاطر عدم إجراء الجراحة؟

على الأرجح سيزداد حجم الفتق (التورم). وقد يحدث احتجاز أو انسداد لجزء الأمعاء المحتبس داخل الفتق مما يؤدي إلى إصابته بالغرغرينا (انقطاع وصول الدم) وإلى موته. قد يكون ذلك خطيراً جداً ويتطلب تدخل علاجي طارئ وعاجل قد يتطلب إجراء جراحة واسعة للأمعاء.

5. ما هي الخيارات العلاجية البديلة المتوفرة؟

قد يلبس المريض حزام يوفر الدعم للمنطقة الضعيفة من جدار البطن. هذا الحزام ليس شفاء ، كما أن لبسه قد لا يكون مريحاً وقد يسبب الضغط الناتج عنه إلى الإصابة بتقرحات في الجلد ، وهو ليس دائماً فعالاً. إن الاستخدام الأمثل للحزام يتطلب المشورة الطبية.

6. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

7. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

Specific Risks:

- **Convert to open surgery.** The keyhole method may not work. Open surgery in.
- **Damage to large blood vessels, gut or bladder.** The sharp instruments (trocar and cannula) may cause damage when put into the abdomen to provide access and insert gas. Further surgery to repair the damage.
- **Gas bubble.** Gas, which is fed into the abdominal cavity may rarely cause heart and lung complications. This can be life threatening. Drug therapy and careful observation.
- **Trouble passing urine after the operation.** A temporary problem due to spasm of the bladder muscles in 1 in 100. More common in elderly males. A catheter (plastic tube) is put into the bladder to drain the urine away.
- **Swelling of the testicle and scrotum.** In male patients, the testicle and the contents of the scrotum may swell due to tissue damage during surgery or bleeding during or after surgery. Also the penis may show bruising. The swelling of the scrotum may be drained using a needle. it may shrink (1 in 3000 to 1 in 200 for primary repairs and 1 in 20 to 1 in 120 for recurrent repairs).
- **Injury to sperm tube (Vas Deferens).** The tube carrying sperm from the testicle to the prostate may be injured which may reduce fertility in 1 in 100. Results in partial

مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند المرضى ذو الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر بمضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء بالتحديد:

- **التحول إلى الجراحة المفتوحة.** الجراحة باستخدام طريقة "المنظار الجراحي" المذكورة آنفاً قد لا تنجح. يحدث تحول إلى طريقة الفتحة.
- **ضرر يصيب أحد الأوعية الدموية الكبيرة ، الأمعاء أو المثانة البولية.** المعدات الحادة المستخدمة قد تسببان ضرراً عند إدخالهما إلى البطن لإيجاد مدخل يتم من خلاله نفخ البطن بالغاز. يتطلب الأمر جراحة أخرى لإصلاح الضرر.
- **جلطه غازية.** من النادر أن يسبب الغاز الذي يتم ضخه في الفراغ البطني مضاعفات للقلب أو الرئة ، وفي حالة حدوث ذلك فإن الأمر يكون خطير ومهدد للحياة ويتطلب علاج بالأدوية وملاحظة شديدة.
- **وجود مشكلة في التبول بعد الجراحة.** مشكلة مؤقتة بسبب تشنج يصيب عضلة المثانة البولية (1 من كل 100 مريض). وهو أكثر شيوعاً عند كبار السن. يتم وضع قسطرة بولية (أنبوب بلاستيكي) في المثانة لتصريف البول.
- **تورم في الخصية و (كيس) الصفن.** عند الرجال قد تتورم الخصية والكيس المحيط بها بسبب ضرر يصيب الأنسجة أثناء الجراحة أو بسبب نزيف يحدث أثناء أو بعد الجراحة. وقد يصاب العضو الذكري بكدمات أيضاً. وقد تنكمش (1 في كل 3000 إلى 1 في كل 200 ممن يخضعون لإصلاح الفتق للمرة الأولى ، و 1 من كل 200 إلى 1 من كل 120 يقومون بتكرار الخضوع للجراحة).
- **حدوث إصابة للأنابيب المنوية.** قد يتضرر الأنبوب الذي يحمل الحيوانات المنوية من الخصية إلى البروستاتا وقد يقلل ذلك من الخصوبة في 1 من كل 100 مريض. قد يؤدي إلى قطع جزئي في القناة الدافقة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

vasectomy.

- **Ongoing pain or discomfort in groin.** One of the small nerves in the groin can be cut or caught in a stitch or scar causing long term burning and aching in the groin in 1 in 50. This may happen straight after surgery.
- **Change to testicle.** The testicle may sit a little higher in the scrotum after surgery. A change in physical appearance.
- **Wound infection.** The wound may become infected the rate of risks is estimated at about 1% or 1 in 100. Wound infections are usually treated with dressings and/or antibiotics.
- **Bleeding into the wound.** Possible bleeding into the wound after the surgery in 1 in 30. Swelling, bruising, blood stained discharge, which may cause pain, or become infected. Treatment is usually antibiotics and/or drainage by further surgery.
- **The wounds may not heal normally.** The scars can thicken and turn red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring. It is more frequent in recurrent hernias.
- **Bands of scar tissue – adhesions.** Bands of scar tissue can form inside the abdomen, which may cause bowel blockage and possible bowel damage. Further surgery may be necessary.
- **Hernia comes back.** The hernia may come back in 1 in 30 to 1 in 100. Further surgery to repair the hernia.
- **Hernias at the wound sites.** Hernias may form where instruments were passed into the abdomen. This may need further surgery.
- **Increased risk in smokers.** Smoking slows wound healing and affects the heart, lungs and circulation. Giving up smoking before the operation will help reduce the risk.
- **Death.** Death is extremely rare due to hernia repair – less than 1 in 10,000.

8. What do I need to know about recovering from this procedure?

- استمرار الألم أو الشعور المستمر بعدم الراحة في منطقة أعلى الفخذ. الأعصاب الصغيرة في أعلى الفخذ قد يتم قطعها أو احتجازها داخل الغرزة الجراحية أو الندب الجراحي مما يسبب شعور طويل الأمد بحرارة وألم في أعلى الفخذ (1 من كل 50 مريض). قد يحدث ذلك مباشرة بعد الجراحة.
- تغيير يصيب الخصية. بعد الجراحة قد تأخذ الخصية موقع أعلى من موقعها السابق داخل كيس الخصية. مما يغير في مظهر الجسد.
- عدوى في الجرح. قد يصاب الجرح بالعدوى. معدل الخطر هو 1% ، أي مريض واحد من بين كل 100 مريض . عدوى الجرح تعالج عادةً بالمضادات و / أو المضادات الحيوية.
- النزيف إلى داخل الجرح. احتمال حدوث نزيف داخل الجرح بعد العملية هو (1 من 30 مريض). تورم ، كدمة ، إفرازات مختلطة بدم ، قد تسبب الألم أو تصاب بعدوى. العلاج غالباً يكون بالمضادات الحيوية و / أو التفريغ الجراحي للتورم .
- عدم التئام الجرح بشكل طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً. يكون هذا بشكل دائم وقد يؤدي ذلك إلى تشوه المنطقة. هو أكثر حدوثاً في حالات الفتق المتكرر.
- الالتصاقات –. أحزمة من الأنسجة الناعمة قد تتكون داخل البطن وقد تسبب انسداد في الأمعاء وأضرار محتملة للأمعاء. قد تكون هناك حاجة لعملية أخرى.
- عودة الفتق. قد يعود الفتق للظهور عند كل 1 من 30 مريض إلى 1 من 100 مريض. تجرى جراحة أخرى لإصلاح الفتق.
- وجود فتوق في مواقع الجروح. قد تنشأ فتوق في المواضع التي تم عبرها تمرير المعدات الجراحية إلى داخل البطن . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- زيادة المخاطر لدى المدخنين. يقلل التدخين من التئام الجرح ويؤثر على القلب والرئتين والدورة الدموية. التوقف عن التدخين قبل العملية يساعد في تقليل من هذه المخاطر.
- الوفاة. الوفاة نادرة جداً بسبب الفتق – أقل من 1 في كل 10000 مريض.

8. ما الذي ينبغي أن أعرفه عن فترة التعافي التي تعقب هذا الإجراء؟

بعد العملية الجراحية ، سيقوم الممرضون برعايتك ومتابعتك إلى

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

After the operation the nursing staff will closely watch you until you have recovered from the anaesthetic. You will then go back to the ward where you will rest until you are well enough to go home. Young, fit patients may be able to go home the same day. Other patients usually go home 24 hours after surgery.

If you have any side effects from the anaesthetic, such as headache, nausea or vomiting, you should tell the nurse looking after you, who will be able to give you some medication to help pain.

Pain

You can expect to have pain in the operation site. The nurse can give you painkillers for this, so it is important to let the nurse know. Your pain should wear off within 7-10 days. If it does not, you must tell your doctor.

Diet

You may have a drip in your arm; this will be removed soon after you recover from the anaesthetic. To begin with, you can take small sips of water, and then slowly take more until you are eating normally.

Wounds

Your wounds may have a small dressing, which will be removed the day after surgery. You can shower the day after surgery. Your wounds will be protected with a dressing, which is either stick-on or spray-on. Stick-on dressings should be replaced if they become dirty or are falling off. Continue to keep your wounds clean and protected until healed and no seepage is present.

Your lungs and blood supply.

It is very important after surgery that you start moving as soon as possible. This is to prevent blood clots forming in your legs and possibly going to your lungs. This can be fatal.

Also, you need to do your deep breathing exercises. Take ten deep breaths every hour to prevent secretions in the lungs becoming stagnant. If this happens, you may develop a chest infection. At all costs, avoid smoking after surgery as this increases your risk of chest infection. Coughing is painful after abdominal surgery.

أن تفريق من التخدير . تؤخذ بعد ذلك إلى وحد التنويم لترتاح إلى أن تصبح قادراً على المغادرة إلى منزلك. المرضى صغار السن من ذوي الصحة الجيدة بإمكانهم العودة إلى منازلهم خلال نفس يوم إجراء العملية. باقي المرضى عادة ما يغادرون المستشفى بعد 24 ساعة من الجراحة.

إذا كان لديك أي مضاعفات جانبية بسبب التخدير مثل الصداع ، الغثيان أو الاستفراغ ، فيجب عليك إبلاغ الممرض الذي يعتني بك والذي بإمكانه إعطائك بعض الأدوية لمساعدتك.

الألم

توقع أن تشعر بالألم في مكان العملية. بإمكان الممرض إعطائك علاج للألم، لذا من المهم إبلاغك الممرض بذلك. من المفترض أن يختفي شعورك بالألم خلال 7-10 أيام ، وإذا لم يختف خلال هذه المدة قم بإبلاغ طبيبك.

النظام الغذائي

قد يتم إعطائك سوائل عن طريق محقنة وريدية. سيتم إزالة هذه المحقنة بمجرد تعافيك من التخدير . إبدأ أولاً بأخذ رشقات صغيرة من الماء ، ثم زد الكمية تدريجياً حتى تعود لنظامك الغذائي السابق.

الجروح

قد يكون جرحك مغطى بضماد صغير والذي ستتم إزالته في اليوم التالي للعملية الجراحية. بإمكانك الاستحمام في اليوم التالي للجراحة. ستتم حماية جلدك بضماد لاصق بإحكام أو بضماد عبارة عن رذاذ بلاستيكي يتم بخه على الجرح. الضمادات اللاصقة يجب تغييرها عند إذا اتسخت أو سقطت. أبق جرحك نظيفاً ومحماً حتى يلتئم دون أن يكون هناك أي رشح أو تسربات منه.

رئتيك و تدفق الدم

من المهم بعد الجراحة أن تبدأ في التحرك بأسرع وقت يمكنك فيه القيام بذلك. يمنع هذا تكون التخثرات الدموية في ساقيك وربما انتقالها إلى رئتيك . قد يكون ذلك مميتاً.

كما أن عليك ممارسة تمارين التنفس العميق. خذ عشرة أنفاس عميقة كل ساعة لمنع ركود الإفرازات الموجودة في الرئة ، لأن حدوث ذلك قد يؤدي إلى عدوى في الصدر.

مهما كان الثمن ، يجب عليك تجنب التدخين بعد الجراحة لأن ذلك يزيد من فرص إصابتك بالتهاب في الصدر. عادة ما يكون السعال مؤلماً بعد عملية جراحية في البطن.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Exercise

Expect to feel tired for a few days after surgery.

You need to take things easy and gradually return to normal duties, as you feel able to. It usually takes about 2 weeks to recover after laparoscopic repair.

You should not drive during the first week. Do not lift heavy weights for at least six weeks after surgery. This is to prevent a rupture where the cuts were made and allow healing to take place inside.

9. What do I need to tell my doctor?

Tell your doctor if you have:

- Large amounts of bloody discharge from the wound/s.
- Fever and chills.
- Pain that is not relieved by prescribed pain killers.
- Swollen abdomen.
- Swelling, tenderness, redness at or around the cut/s.

Notes to talk to my doctor about:

ممارسة التمارين الرياضية

فيما عدا شعورك بالتعب خلال الأيام القليلة التي تعقب الجراحة ، فإن عليك أخذ الأمور بالرفق و العودة تدريجياً للقيام بواجباتك وممارسة نشاطات حياتك اليومية متى ما شعرت بقدرتك على ذلك . عادةً ما تستغرق مرحلة الشفاء لأي جراحة عن طريق المنظار أسبوعين.

لا يجب عليك قيادة المركبات خلال الأسبوع الأول الذي يعقب الجراحة. لا تحمل أوزاناً كبيرة على الأقل لستة أسابيع بعد الجراحة وذلك لمنع حدوث أي تمزق في الأماكن التي خضعت لعمل شق جراحي ولإعطاء فرص لعملية الالتئام الداخلي للجروح.

9. ما الذي ينبغي علي ذكره لطبيبي؟

أبلغ طبيبك إذا شعرت بـ :

- خروج كمية كبيرة من الإفرازات المختلطة بالدم من الجرح/الجروح.
- ارتفاع في درجة الحرارة أو قشعريرة برد.
- ألم لا يختفي مع تناول أدوية الألم الموصوفة. تورم في البطن (انتفاخ).
- تورم ، ألم عند لمس ، واحمرار في أو حول الجرح/الجروح.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
